恵那市 医療MaaS・専門医療連携 実証事業（仮称）への参画について（ご相談）

学校法人 藤田学園 藤田医科大学 御中

令和8年11月　恵那市 医療福祉部 地域医療課

検討段階の資料です。内容は貴学とのご協議を踏まえて見直します。

1. ご相談の趣旨

岐阜県恵那市では、医療機関の無い中山間地域でも、**かかりつけの総合診療と、必要なときの専門医療**を受けられる体制づくりを進めています。その第一歩として、国の**地域未来交付金（令和9年度当初分）**を活用した実証事業を計画しています。

本事業では、**市立恵那病院（指定管理者：公益社団法人 地域医療振興協会）を住民に最も近い「フロントエンド」**とします。そのうえで、専門医療・先進医療に積極的に取り組まれている**貴学に、専門医療の「バックエンド」としてオンラインでご参画いただきたい**と考えています。事業の方向性と、ご参画の可能性についてご相談申し上げます。

2. 背景

- 恵那市は中山間地域が広く、串原・山岡・飯地・笠置など**医療機関の無い地域**で人口減少と高齢化が進んでいます。
- 市内では常勤の専門医がいない診療科があり、専門的な判断が必要な患者は**遠方の病院へ通院・転院**せざるを得ない状況です。
- 市は「恵那市地域医療ビジョン」（令和6年3月）と「恵那モデル実施計画（案）」（令和7年5月）で、移動診療車とオンライン診療の導入検討を位置づけています。
- 地域の総合診療と大学の専門医療をオンラインで結ぶことで、**専門医の移動なしに専門的な判断を地域へ届けるモデル**を、全国の中山間地域に示したいと考えています。

3. 事業の概要

恵那市地域医療ビジョン「恵那モデル」の具体化

恵那市 医療MaaS・専門医療連携 実証事業（仮称）

庁内・関係者説明用（案）

令和8年11月　恵那市 医療福祉部 地域医療課
申請予定：地域未来交付金（令和9年度当初分）

目指す姿：住んでいる場所にかかわらず、かかりつけの総合診療と、必要なときの専門医療が受けられる恵那市 ― 2035～2040年を見据えて ―

背景・課題

- **医療機関の無い地域**（串原・山岡・飯地・笠置など）で人口減少・高齢化が進行
- 免許返納・公共交通の縮小で**通院そのものが困難**な高齢者が増加
- 地域では常勤の**専門医がいない診療科**があり、遠方の病院への通院・転院が負担
- 処方薬の受け取りにも通院と同じ移動負担

市の計画との関係

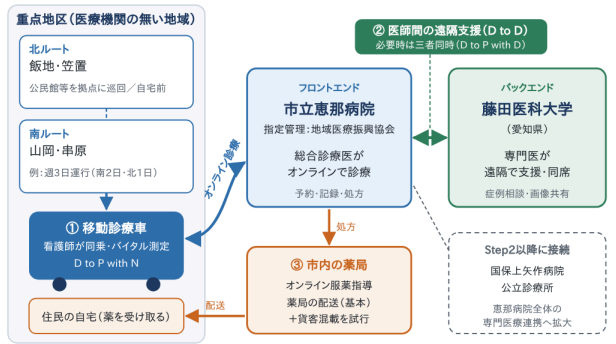
- 恵那市地域医療ビジョン（令和6年3月）
- 恵那モデル実施計画（案）（令和7年5月）
  → **移動診療車（D to P with N）の導入検討**、オンライン診療の導入を位置づけ済み
- 岐阜県 東濃圏域推進区域対応方針（令和7年2月）

推進体制

恵那市	申請・統括、住民周知
恵那病院（協会）	総合診療医・看護師、車両運用
藤田医科大学	専門医の遠隔支援、学術評価
医師会・薬局	診療連携、服薬指導・配送
地域・介護・交通	対象者把握、運行・配送

「（仮称）恵那市医療MaaS推進協議会」を令和8年度中に設置（岐阜県はオブザーバー）

事業の仕組み：恵那病院（フロント）と藤田医科大学（バック）をオンラインで結ぶ



① 医療MaaS
看護師が同乗した車両が地区を巡回し、車内で恵那病院の医師がオンライン診療

② 医師間の遠隔支援
恵那病院の医師が藤田医科大学の専門医に相談。初年度は1～2診療科から

③ 服薬指導＋薬の配送
薬局がオンラインで服薬指導し、薬を自宅へ届ける

住民 通院しなくても、地元でかかりつけ医と専門医に診てもらえる

医療 限られた医師・看護師で広い地域をカバーできる

地域 全国の中山間地域に展開できる「恵那モデル」になる

段階的な展開

R8	R9	R10	R11～
準備・協定・推進協議会・申請	医療MaaS実証開始（①②③）	専門連携の拡大、上矢作病院等を接続	診療報酬・市予算で自走、横展開

事業費（概算・3か年）

年度	事業費	主な内容
R9	2,080万円	車両・機器、システム構築、運行
R10	880万円	運行、連携拡大
R11	730万円	運行、評価・横展開
計	**3,690万円**	**上限4,000万円以内**

補助率1/2の場合、市負担は約1,850万円（R9 約1,040万円）。金額は見積前の概算。

成果指標（KPI）案

- 移動診療車の訪問件数・利用者満足度
- 利用者の通院時間・費用の削減
- 専門医との遠隔相談件数、遠方への受診・転院の回避件数
- 処方から薬を受け取るまでの日数
- 医師の移動時間の削減
- 実証後の継続運行・横展開

※ 本資料は検討段階の案です。関係機関との協議・交付金要件の確認により変更する場合があります。

恵那市 医療福祉部 地域医療課

項目	内容（案）
事業名	恵那市 医療MaaS・専門医療連携 実証事業（仮称）
重点地区	医療機関の無い地域（串原・山岡・飯地・笠置 など）
実証テーマ	① 医療MaaS（看護師が同乗する移動診療車で、恵那病院の医師がオンライン診療） **② 医師間の遠隔支援（恵那病院と貴学の D to D、必要時は三者同時の D to P with D）** ③ オンライン服薬指導＋薬の配送
期間	令和9～11年度（3か年）。令和8年度は準備
事業費	3か年で約3,700万円（上限4,000万円）。うち交付金を約1/2と想定

段階的な展開と貴学との連携

段階	時期	貴学との連携（案）
Step0 準備	令和8年度	対象診療科・運用方法のご協議、協定の締結準備

段階	時期	貴学との連携（案）
Step1 医療MaaS実証	令和9年度	**1〜2診療科**で、移動診療車の患者について恵那病院の医師からの相談・同席診療を試行
Step2 専門連携の拡大	令和10年度	恵那病院の外来・入院の患者に連携を拡大（診療科の追加、画像等の共有、専門外来のオンライン化）
Step3 恵那モデルの確立	令和11年度〜	恵那病院全体が専門医療機関と常時つながる仕組みとして定着。東濃圏域などへの展開

4. 貴学にお願いしたい役割（案）

役割	内容（案）
専門医による遠隔支援（D to D）	恵那病院の医師からの症例相談への助言、心電図・画像・写真などの確認
三者同時の診療（D to P with D）	必要時に、移動診療車・恵那病院の患者の診療にオンラインで同席
定期の症例カンファレンス	例：月1〜2回、オンラインで恵那病院の医師と症例を検討（教育的な効果も期待）
実証の学術的な評価	効果検証の設計・分析へのご協力（共同研究・論文化の可能性）
推進協議会への参画	委員として計画づくり・効果検証に参加

対象診療科の考え方（案）

初年度は**1〜2診療科**から始めることを想定しています。次の3つの観点から、貴学と協議して決めたいと考えています。

1. 恵那病院で常勤医がいない、または少ない診療科
2. 重点地区の高齢者に多い疾患（例：心不全・不整脈、糖尿病・腎臓病、認知症・神経疾患、皮膚疾患）
3. オンラインで判断しやすい診療科（心電図・画像・写真を共有できる。例：循環器、皮膚、画像診断）

市外の専門病院に通院している市民の診療科などのデータは、今後市で整理してご提示します。

5. 費用・協定の考え方（案）

- 専門医のご対応にかかる費用は、**謝金または委託料として市が負担**する想定です。交付金の対象経費とする方向で調整します。
- オンライン連携に必要なシステム（映像・画像の共有）は、市が交付金を活用して整備します。貴学側の環境整備のご負担はできるだけ小さくなるよう設計します。
- 県境を越える連携となるため、**市・地域医療振興協会・貴学の三者で協定**を結ぶことを想定しています。協定では、役割、費用、責任分担、個人情報の取扱いを定めます。
- 医療情報の取扱いは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などに沿って運用します。

6. 今後のスケジュール（案）

時期	内容
令和8年11～12月	貴学・地域医療振興協会へのご相談、内閣府・岐阜県への事前相談
12～1月	推進協議会の設置、対象診療科・運用方法のご協議
1～3月	交付金の申請（申請書に貴学の参画を記載させていただきたい）、協定内容の調整
令和9年4月～	交付決定、システム整備、運用手順の作成
令和9年秋（目標）	移動診療車の運行開始と、専門医連携の試行開始

7. ご検討いただきたい事項

1. 本事業へのご参画の可能性と、ご担当の窓口（診療科・部署）
2. 対象とする診療科と、ご対応いただける専門医・時間帯の目安
3. 遠隔での相談・同席診療・カンファレンスの運用方法（予約制・随時など）
4. 費用の考え方（謝金・委託料の水準、契約の形態）
5. 協定の形態（三者協定、連携協定など）と学内の手続き・所要期間
6. 学術的な評価・共同研究へのご関心
7. 交付金の申請書に、貴学の参画（予定を含む）を記載してよいか

お問い合わせ先

恵那市 医療福祉部 地域医療課　担当：〇〇〇〇　電話：〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇　メール：〇〇〇〇